جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سحر محمود عبدالجليل خطاب

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** اخري **العنوان :** -

رقم البطاقة : 28603062101247 **رقم التليفون :** 01227677587 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 06-03-1986**المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(---------------------------**)**

المقر بما فيه
التوقيع:(---------------------------**)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ---------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** --------------------------- **التوقيع:** د/محمد كيلاني ---------------------------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** --------------------------- **التوقيع:** د/ندى حسن ---------------------------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** --------------------------- **التوقيع:** نرمين رمضان ---------------------------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ------------------------ **ا.د/** ------------------------ **د/** ------------------------ **د/** ------------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --

خطة العلاج : --

المستشفي : -- **قسم :** --

جهة العلاج : -- **نفقات :** --

ملاحظات : ---

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

Name: سحر محمود عبدالجليل خطاب
National ID: 28603062101247

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

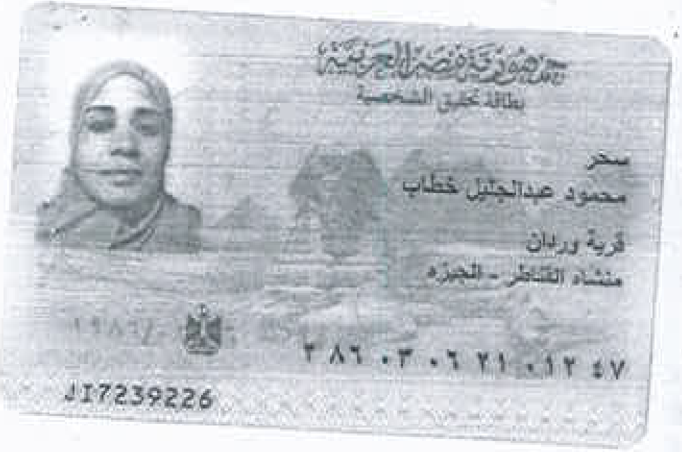
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : yyyy-mm-dd --:-- --	**تاريخ وساعة الخروج :** 05-07-2026 01:17 PM

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

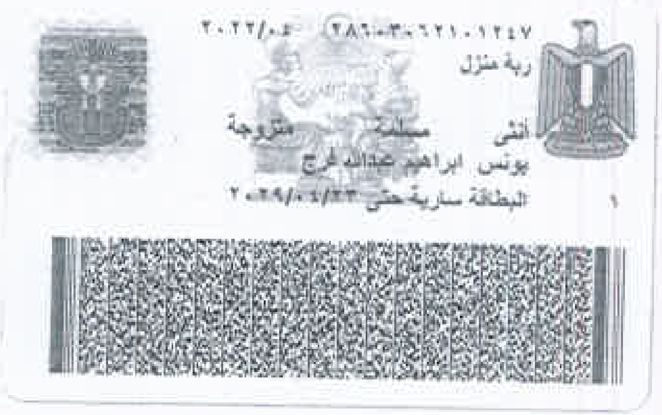


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

سحر
محمود عبدالجليل خطاب
قرية وردان
منشاه القناطر - الجيزه

٢٨٦٠٣٠٦٢١٠١٢٤٧

JI7239226



٢٨٦٠٣٠٦٢١٠١٢٤٧ ٢٠٢٢/٠٤
ربة منزل
انثى مسلمة متزوجة
يونس ابراهيم عبدالله فرج
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٤/٢٣

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

Patient ID:
Name : سحر محمود عبدالجليل عطا
Sex: Female
3- Medical number: 83190695
Old Med : 667/2024
Patient Age : 39 Y
Diagnosis:

Family history	Family History -ve	Phone	01226646864	BMI		REASON OF MDT	POST OPERATIVE
Lactation status		NRS Score		GROUP		Date of MDT	07/12/20
Co morbidity	Co Morbidity -ve	Menopausal status		Initial STAGE			

Clinical data

Breast Imaging : [illegible] 12 o'clock UOQ 2.5*4 CM AND [illegible] 3P LNS	Mets Workup : CT CAP:FREE

DX DX Comment	ER 8/8 ER COMMENT	PR 8/8 PR COMMENT	Her 2 Neu 3 Her 2 Neu COMMENT	SISH SISH COMMENT	Ki67 50

cT2	N 0	M 0

Sonomammography

PATIENT HISTORY
pt received 6 TC last 28/8/2024 + 4 phesgo
3/11/2024 RT SSM +SLNB:
ypTis N0
LN 0/5
free skin , resection margin

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN
in view of PCR for
adj herceptin 600 S.C x 17
-no role for PORT
-adj AI / zoladex

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/ [illegible]	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/ [illegible]
SURGERY	SURGERY د/ [illegible]	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

Name: سحر محمود عبد الجليل خطاب
MR. : 6461

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من
بشأن تقرير طبي للمريض

بقسم:
رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :
تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was prescribed letrozole (Femara) in combination with supportive care for a duration of three months, and a dose of goserelin acetate (Zoladex) was administered on 3 August 2026. The next clinic visit is scheduled for 7 September 2026.

تحريرا في ,

التاريخ : 21-09-2026
الوقت :
الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

وزارة الصحة و
المتخصصة الطبية

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name : جد الجليل الأستاذه / سـ
Patient No. : 28603C [illegible]01247
Path No. : 585/24
Sex : Female
Age : 37 Y
Referreing Doc. :

Request No. : 13006517
Request Date : 12/02/2024
Verification Date : 25/02/2024
Financial Category : ملام - مبادره
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : .marwa mo

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Right breast mass at 12 oclock
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 11/2/2024 at 11:05 a.m .

Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (V stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultraview HRP DAB as chromogen and hematox counter-stain. The sections were treated against: ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (Ki67 clone (30-9).

Results:
IPT (Positive control sho[illegible] appropriate reactivity):
ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8).
PR: Strong nuclear reaction in 90% tumor cells (Allred score 8/8).
Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).
Ki67: 50% nuclear reac[illegible] tum[illegible]

Conclusion:
Right breast cancer, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade III, with focal DCIS.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 50% of tumor cells.
- Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells stainin staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	الأستاذه / سحر محمود عبد الجليل
Patient No.	28603062101247
Path No.	585/24
Sex	Female
Age	37 Y
Referreing Doc.	

Request No.	13006
Request Date	12/02/
Verification Date	25/02/
Financial Category	- مبادره
Department	Out Pa
Registered by	.marwa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPOR

5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, we intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her ."

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by observed or membrane sta[illegible] that is incomplete and is faint/barely perceptible and within the invasive tumor cells. [illegible]: as defined by incomplete membrane staining that is faint/b perceptible and within < 1[illegible] invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential m staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cell complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the inva cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% cells.

Signature
Prof .Dr.Amal Hareedy
Dr.Heba Hassan

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

ـحة والسكـان
الطبية المتخصصة
ورام دار السلام
ة الأشعة

Total DLP (mGy.cm): 1392

Patient Name: Sahar Mahmoud Abd Al Galeel	
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Date : 28/02/2024
Medical ID: 667/2024	Age : 38 Year(s)
	47319

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Right breast upper central solid mass lesion measuring about 3.5 x 2.2 cm.
- Few small prominent right axillary lymph nodes largest measuring 1 x 0.5 cm.
- Few left upper lobe calcified pulmonary nodules likely old granuloma.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

مكـــان
تخصصة
السلام

Total DLP (mGy.cm): 1392

Patient Name: Sahar Mahmoud Abd Al Galeel	Date : 28/02/2024
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Age : 38 Year(s)
Medical ID: 667/2024	47319

- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defe diverticular outpouching.
- IUCD is seen.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Left iliac bone island.
- No suspicious osseous lesions.

Opinion:

- **Right breast lesion with ipsilateral smal promi axillary lymph nodes.**
- **No evidence of pulmonary, hepatic or oss metastasis on non contrast basis.**

Dr. Ali Saber, MSc.

Dr. Amr Farouk, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

PP

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام

Echo report

سمر محمود

Name:

/ 2025 Age:

EF	76 %	54-74%	PWT		0.6-1.1cm
LVEDD	42	3.6-5.7cm	AO		2.0-3.7cm
LVESD	23	2.2-4.0cm	LA	33.	1.9-4.0cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm (supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

dimensions:

wall thickness:

diastolic function:

MA

size

root dimension

Valve

valve

uspid valve

monary valve

side size and systolic function

cardiac masses and thrombi

cardium

diameter and collapsibility.

usion:

Trivial MR. MV prolapse

max PG = 67 mmHg

RVSP = 20 mmHg

mild TR

[redacted]